DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JORGE ANTONIO MUÑOZ CIFUENTES **Identificación** CC 14958459
Edad: 77 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 05/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	Y53	

Cirujano: ALVARO SALAZAR CORREA **Especialidad:** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES269 ALVARO SALAZAR CORREA **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K291 OTRAS GASTRITIS AGUDAS

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 05/11/26 **Fecha Final** 05/11/26
Hora Inicio 15:10:00 **Hora Final** 15:20:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

PREVIA EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO, SUS RESPECTIVOS RIESGOS, POSIBLES COMPLICACIONES Y VERIFICACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO, SE COMPRUEBA QUE TODO EL PERSONAL QUE ACTUARA EN ESTE PROCEDIMIENTO CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) A CONTINUACION SE PROCEDE A UBICAR EL PACIENTE EN DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. SEDACION IV SUMINISTRADA POR ANESTESIOLOGO, SE INTRODUCE EGD HASTA SEGUNDA PORCION DE DUODENO SIN ACCIDENTES Y EN RETROVISION SE DESCRIBEN HALLAZGOS. SE DA PÓR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO CON EL PACIENTE ESTABLE Y SIN COMPLICACIONES. NOTA: DE NO HABER TRASGREDIDO EL AYUNO, SE SUGIERE CONSIDERAR POSIBILIDAD DE GASTROPARESIA.
"ESOFAGO: DE FORMA Y DISTENSIBILIDAD NORMAL MUCOSA CON PEQUEÑAS LESIONES ELEVADAS DE 2 MM DE DIAMETRO TIPO PAPULAS BLANQUECINAS.
. UNION ESOFAGOGASTRICA (EG) A 38 CM. DE ARCADA DENTARIA SUPERIOR (ADS), EN RELACION AL HIATO. ESTOMAGO: LAGO GÁSTRICO ABUNDANTE CON RESTOS DE ALIMENTOS, LO CUAL IMPIDE UNA OPTIMA VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUCOSA DE FONDO Y CUERPO PROXIMAL. LA MUCOSA DE CUERPO DISTAL Y ANTRO ERITEMA LINEAL. PILORO CENTRAL Y PERMEABLE. DUODENO: MUCOSA DE PRIMERA Y SEGUNDA PORCION SIN ALTERACIONES APARENTES."
BIOPSIA DE MUCOSA DE CUERPO Y ANTRO GASTRICO
IMAGEN COMPATIBLE CON: 1) GASTRITIS AGUDA CORPOROANTRAL

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐
BIOPSIA DE MUCOSA DE CUERPO Y ANTRO GASTRICO

ALVARO SALAZAR CORREA
Reg. 13145
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

***** FIN DEL REPORTE *****